

Model *I-PACE*

Najlepiej udokumentowany model wyjaśniający przejście z normalnego korzystania z pornografii do problematycznego. Cztery filary podatności, jeden cykl utrzymujący.

CZAS: 30 min czytanie Psychoedukacja — fundament

ŹRÓDŁO: Brand i wsp. (2016, NBR); Brand i wsp. (2019, IJERPH)

JAK UŻYWAĆ

Model I-PACE (*Interaction of Person-Affect-Cognition-Execution*) — wprowadzony przez Branda i wsp. (2016) jako próba ujednolicenia teorii problematycznego używania pornografii (PPU) i innych zachowań cyfrowych. Pokazuje: 1) **cechy osoby**, które tworzą podatność, 2) **afekt** (stany emocjonalne) jako wyzwalacz, 3) **poznanie** (oczekiwania, przekonania) jako mediator, 4) **wykonanie** (zachowanie + decyzje) jako efekt. Karta porządkuje 4 filary i pokazuje, gdzie konkretnie pracujemy terapeutycznie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Przed modelem I-PACE istniało **kilkanaście niezgodnych teorii** PPU: model uzależnieniowy, model niespójności moralnej, model dual control, model niedoboru dopaminy. Brand i wsp. (2016, *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*) zaproponowali model **integracyjny** uznawany dziś za standardowy w obrębie WHO i większości badań empirycznych. I-PACE pozwala na *indywidualne formułowanie przypadku*: u tego pacjenta podatność leży głównie w cesze X, wyzwalaczem afektywnym jest Y, mediatorem poznawczym Z, a deficyt wykonawczy widać w obszarze W. Każdy obszar wymaga innej interwencji.

01 📖 Cztery filary modelu I-PACE

P · PERSON (OSOBA)

cechy tworzące podatność

Genetyka, neurobiologia, cechy osobowości (impulsywność, poszukiwanie nowości), wczesne doświadczenia (trauma, deprywacja, ekspozycja na materiały seksualne w dzieciństwie), współistniejące zaburzenia (ADHD, lęk, depresja).

Co modyfikujemy: psychoterapia osobowości, leczenie współwystępujących zaburzeń.

A · AFFECT (AFEKT)

stany emocjonalne wyzwalające

Stres, nuda, samotność, lęk, gniew, smutek. Także stany pozytywne: ekscytacja, świętowanie. Pornografia staje się *narzędziem regulacji*.

Co modyfikujemy: uczymy regulacji emocji bez pornografii (DBT, uważność, terapia emocji).

C · COGNITION (POZNANIE)

oczekiwania i przekonania

„Tylko porno mnie zrelaksuje”, „nie poradzę sobie z tym napięciem”, „jestem zboczeńcem”, „i tak nie ma sensu się hamować”. Atencyjne uprzedzenie do bodźców seksualnych.

Co modyfikujemy: klasyczne CBT — kwestionowanie przekonań, eksperymenty.

E · EXECUTION (WYKONANIE)

decyzja + zachowanie

Oslabiona kontrola wykonawcza — kora przedczołowa „nie wystarcza”, by zatrzymać impuls. Automatyczne sięganie po telefon, otwieranie strony, decyzja podjęta przed świadomością.

Co modyfikujemy: umiejętności kontroli impulsów, środowiskowe modyfikacje (blockery, urlop od ekranu).

02 🔄 Cykl I-PACE — jak utrzymuje się PPU



cykl: każdy sukces wzmacnia ścieżkę → następnym razem łatwiej, automat głębszy

03 Twoja mapa I-PACE — autoanaliza

Wypełnij swoją osobistą wersję modelu. To pomoże Tobie i terapeutce zidentyfikować, *gdzie konkretnie* najsilniej potrzebna jest praca.

P • MOJE CECHY OSOBOWOŚCI

— impulsywność, lęk, depresja, ADHD, trauma

A • MOJE STANY WYZWALAJĄCE

— jakie konkretnie emocje poprzedzają sięgnięcie

C • MOJE PRZEKONANIA

— co mówię sobie w głowie tuż przed

E • MOJA SEKWENCJA DZIAŁAŃ

— co dokładnie robię, krok po kroku

04 Mój najsłabszy filar — priorytet pracy

KTÓRY Z 4 FILARÓW JEST U MNIE NAJSILNIEJSZY

— gdzie utrzymuje się cykl

JAKIEJ INTERWENCJI POTRZEBUJĘ NAJPIERW

— P: terapia osobowości / A: regulacja emocji / C: CBT / E: kontrola impulsów

Klucz: Brand i wsp. (2019, *International Journal of Environmental Research and Public Health*) w przeglądzie 116 badań wykazali, że model I-PACE **wyjaśnia 60-70% wariancji** w przejściu od używania do problematycznego używania pornografii — istotnie więcej niż konkurencyjne modele jednoczynnikowe. Praktyczna implikacja: *terapia nie powinna celować w „uzależnienie”, tylko w konkretne filary I-PACE*, które u danego pacjenta są najsłabsze. To pozwala dobrać metodę pod osobę, a nie pod etykietę diagnostyczną. Model jest też podstawą diagnostyki CSBD w ICD-11 (WHO 2022).